



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: SAMUEL PALACIO		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: UROLOGÍA	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: **CIRCUNCISIÓN**

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

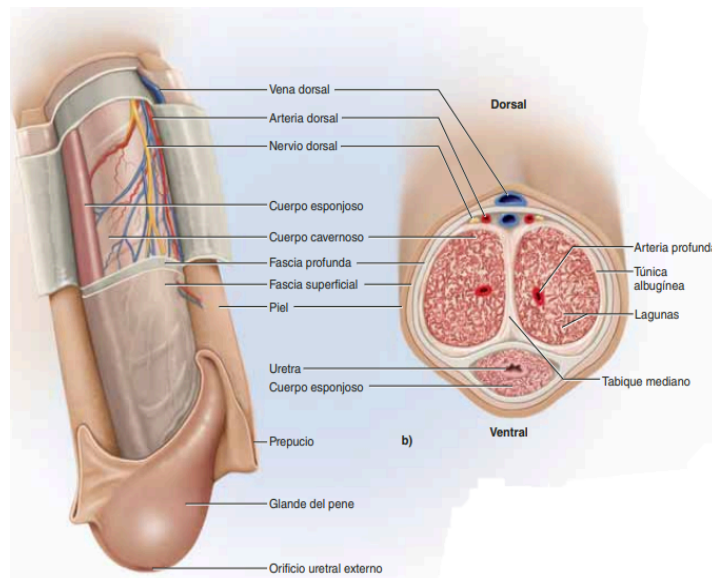
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

La circuncisión es una cirugía para quitar el prepucio, la piel que cubre la punta del pene.

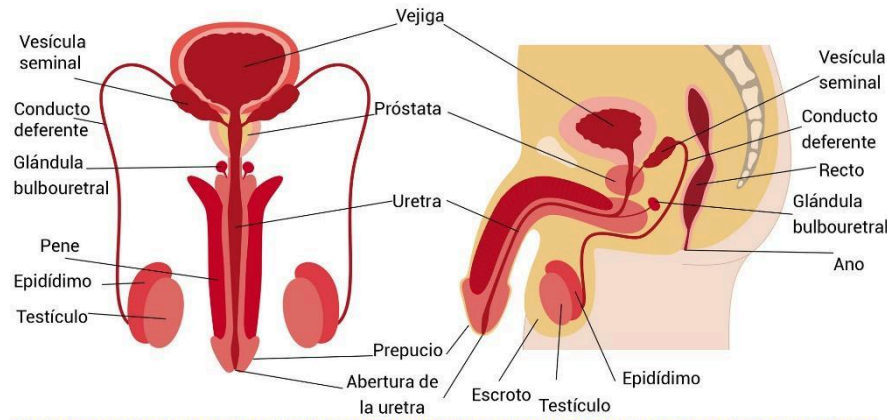
1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



El pene es un órgano externo del aparato reproductor masculino compuesto por varias estructuras anatómicas, En su base se encuentra la raíz, que conecta el pene a la pelvis; el cuerpo es la parte media, compuesta por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos son tejidos cilíndricos que se llenan de sangre para provocar una erección

que se extiende hasta el glande, o punta del pene, el glande es la cabeza expandida en el extremo distal del pene, con un orificio uretral externo en su punta. La parte externa mide 8 a 10 cm de largo y 3 cm de diámetro cuando está flácido (sin erección); las dimensiones típicas de un pene erecto son de 13 a 18 cm de largo y 4 cm de diámetro.

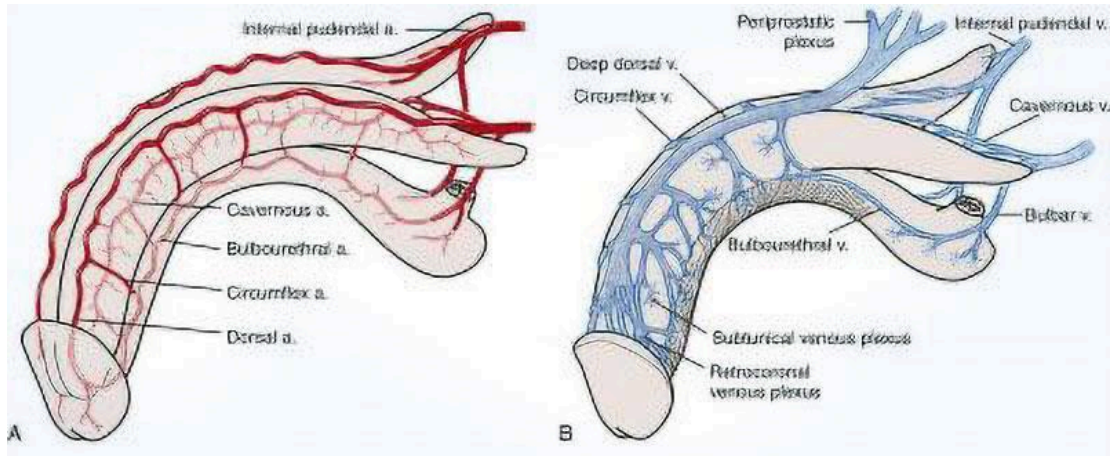


Genitales Externos:

- Pene (compuesto por 2 cuerpos cavernosos y 1 cuerpo esponjoso) que se encuentra recubierto por el prepucio. Su cabeza se llama glande
- Escroto que recubre los testículos

Genitales Internos:

- Testículos: forman las células sexuales o gametos (espermatozoides)
- Epidídimo: donde se entrenan los espermatozoides
- Conducto deferente: Transportan los espermatozoides
- Vesículas Seminales y Próstata: Les dan alimento a los espermatozoides.
- Uretra: Transportan los espermatozoides hacia el exterior a través del pene



El pene está irrigado por ramas de la arteria pudenda interna, que a su vez es una rama de la arteria ilíaca interna. La sangre sale del pene por venas.

irrigado
de la



ARTERIAS QUE IRRIGAN EL PENE

- **Arteria peneana común:** Rama de la arteria pudenda interna que irriga las estructuras profundas del pene
- **Arteria bulbo uretral:** Irriga el bulbo, uretra, cuerpo esponjoso y glándula
- **Arteria dorsal del pene:** Irriga el glándula, cuerpo esponjoso y uretra
- **Arteria cavernosa:** Irriga los cuerpos cavernosos, que se llenan de sangre durante la erección
- **Arteria del bulbo del pene:** Irriga la porción posterior del cuerpo cavernoso y las glándulas bulbo uretrales

VENAS QUE DRENAN EL PENE

Vena pudenda externa superficial, Vena dorsal profunda del pene.

Función de las arterias en la erección

- Durante la erección, las arterias se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo al pene
- La sangre llena los cuerpos cavernosos, lo que produce la erección

INERVACIÓN DEL PENE

- Los nervios pudendos y los nervios cavernosos son los responsables de la inervación del pene
- Los nervios pudendos se encargan de la inervación motora y sensitiva
- Los nervios cavernosos son los responsables de la función eréctil

FISIOLOGÍA

La erección es un proceso **neurovascular** con fases:

- **Estimulación:** Estímulos sensoriales o mentales activan el sistema parasimpático (S2-S4).
- **Liberación de óxido nítrico (NO):** El NO relaja el músculo liso de los cuerpos cavernosos.
- **Vasodilatación:** Aumento del flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos.
- **Compresión venosa:** La sangre queda atrapada al comprimirse las venas, produciendo la erección.

Fisiología de la eyaculación: Tiene dos fases:

- **Emisión** (control simpático): transporte del semen hacia la uretra prostática.
- **Expulsión** (control somático): contracciones rítmicas del músculo bulbo cavernoso y otros músculos perineales.

6. Relajación (Detumescencia)

- Tras la eyaculación, se activa el sistema simpático.
- La vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo, y el pene retorna a su estado flácido.

1.3. Lista de chequeo:

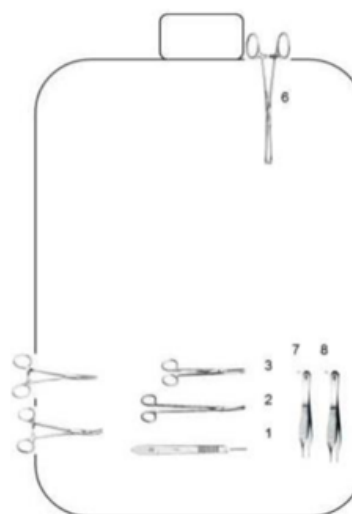


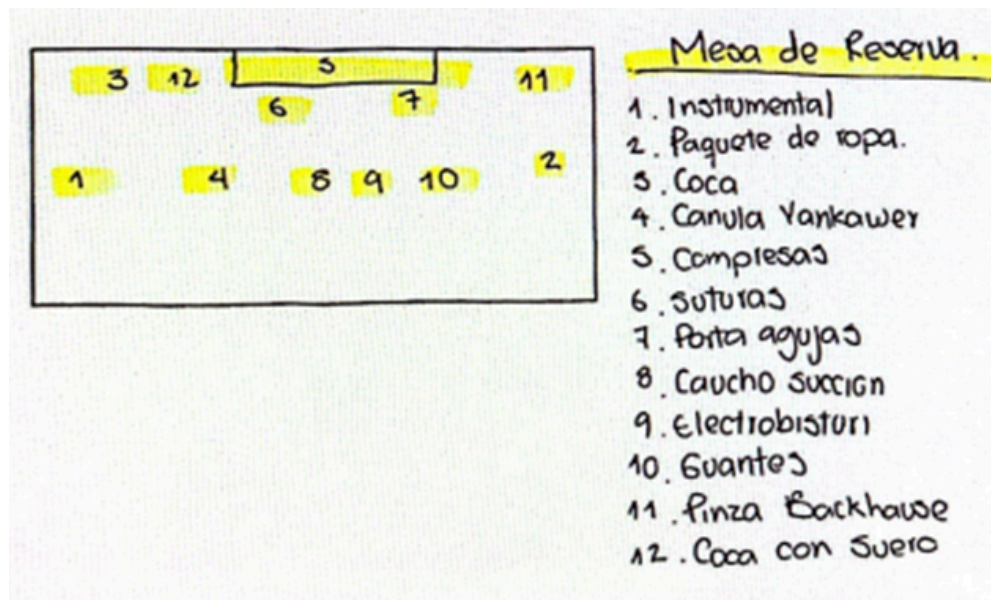
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	Paquete de ropa Electrobisturi Guantes Gasas H.B #10 (adulto) H.B #15 (niños) Aseptojeringa Compresas Caucho de succión Canula de yankawer	Piel y los injertos: Catgut cromado 3/0 aguja de ½ circulo punta redonda. (adulto)	Suero fisiológico al 0.9% Solución salina
		Catgut cromado 4/0 aguja de ½ circulo punta redonda. (niño)	

- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

Mango de Bisturí 3 Hoja 15
2.Tijeras de Metzembraum
3.Tijeras de Mayo recta
4.Pinzas Kelly curva
5.Pinza Kelly recta
6.Pinzas Allix
7.Pinza de Disección Adson sin|
8.Pinzas de Disección Adson





2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decúbito supino



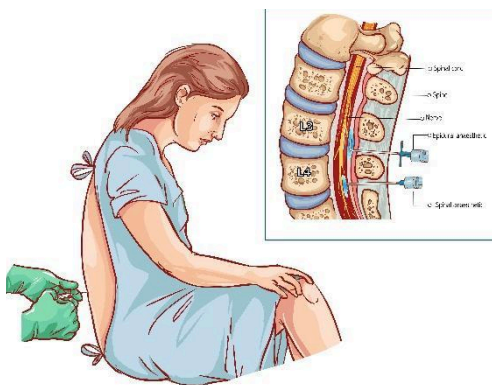


2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



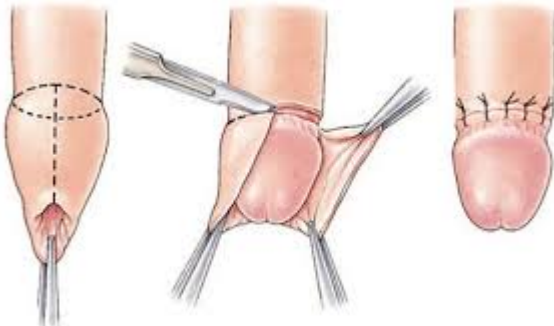
- ETAPA DE EJECUCION:

- **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):** Anestesia general (niños), Anestesia raquídea o bloqueos (adulto)





- **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):** Abordaje en pene, prepucio



- **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA	INSTRUMENTAL
Se toma el prepucio y se tracciona hacia arriba	Pinza mosquito curva
Se delimita la unión coronal sobre la piel y se incide circunferencialmente, siguiendo la “v” del frenillo en la superficie ventral	M.B #3 H.B #15
Retracción del prepucio	Tijeras de plastia
Incisión en la piel y mucosa	Tijeras plastia, Disección Adson con garra
Disección de la piel	Tijeras plastia, Disección Adson con garra
Se delimitan las adherencias y se realiza la incisión circunferencial en la piel, mucosa justo próximamente al surco coronal	Tijeras plastia, Disección Adson con garra
Disección de piel y se retira la piel sobrada entre las dos incisiones y hemostasia	Tijeras plastia, Disección Adson con garra, Electrobisturi
Sutura y curación	Catgut cromado 4/0 con aguja curva redonda medio circulo pequeña, Portaagujas, Tijeras de Mayo, Gasas